

Exclure causes somatiques : ← Symptôme de psychose

Toxiques, infectieuses,
encéphalite, métastases, ...

Apparition dans un contexte
de symptômes thymique

NON

OUI

• Trouble psychotique
aigu et transitoire

Psychoses non-affectives

• Folie à deux ou
Trouble délirant induit

• Psychose du
post-partum

Facteur déclenchant et
apparition subite

NON

Seulement délirant

OUI

NON

Trouble délirant persistant

- ↳ Délinzation (souvent paranoïde ou de grandeur)
sans autres symptômes psychotiques
- ↳ Faible réponse aux neuroleptiques

Schizophrénie

- ↳ Symptômes psychotiques (positifs) dans les phases aiguës
souvent hallucinations auditives avec voix à la 3^e personne
formulant des commentaires sur le comportement du patient
proferant des menaces
- ↳ Symptômes négatifs [affect aplati; alogie; apathie; anhédonie et retrait social]
- ↳ Troubles cognitifs
- ↳ Pdt plus d'un mois

• Épisode dépressif majeur
avec symptômes psychotiques

• Épisode maniaque avec
symptômes psychotiques

Disparition des
symptômes psychotiques
avec résolution épisode thymique

NON

• Trouble schizo-affectif

1. Présence conjointe de :

- Symptômes affectif (manie ou dépression)
- Symptômes psychotiques

2. Persistance des symptômes psychotiques
au-delà de 2 semaines après la
résolution de l'épisode affectif

STATUS

1. Présentation, impression générale

Biotype, corpulence, posture, démarche
 Aspect général, signes physiques, signes cutanés, hygiène, âge (fait-il son âge ?)
Tenue vestimentaire (soigné, neutre, terne, négligé, fantaisiste, correspondant à la personne)

2. Attitude et contact

Qualité de la relation : superficielle, bonne, chaleureuse, mauvaise, froide, bizarre, inadéquate

Attitude : indifférent, passif, collaborant, coopérant, soumis, dépendant, séducteur, manipulateur, distant, contre-dépendant, opposé, méfiant, hostile, agressif, infantile, puéril, ludique

Distance relationnelle : spontané, ouvert, inhibé, renfermé, désinhibé, envahissant, collant, réticent

Modulation de la relation : souple, adéquat, rigide, stéréotypée, inadéquate, chaotique, incohérente

3. Trouble de la conscience / vigilance

Baisse de la vigilance (obnubilé, somnolent, torpeur, coma), dissolution de la conscience, rétrécissement de la conscience (sujet fixé ou fasciné par une expérience interne ou externe précise), expansion de la conscience (subjectif)

4. Trouble de l'orientation

Capacité à se situer dans l'espace, dans le temps, sur la situation et sur sa personne (4 modes)

5. Troubles de l'attention et de la mémoire

Attention : soutenue, focus de l'attention partagé ou pas, peut se rappeler et évoquer, suivre la conversation, rester sur une tâche ou une activité

Trouble de l'attention = atteinte de

- 1) L'aperception (capacité à interpréter des proverbes, histoires en images ou fables)
- 2) De la concentration → examen ; test de soustraction
- 3) De la fixation (capacité à fixer des informations nouvelles durant une période d'environ 10 minutes)
- 4) De l'évoocation (capacité d'enregistrer à long terme des impressions ou expériences ou d'évoquer ce qui a été appris, durée > 10 minutes)

Mémoire : amnésie antérograde / rétrograde, confabulation, paramnésie (déjà vu, entendu ou vécu, jamais vu, entendu ou vécu).

6. Psychomotricité

Ralentissement (diminution, inhibition du dynamisme)
Augmentation du dynamisme → accroissement énergie, initiative, intérêt
Agitation motrice (anxieuse, maniaque, confuso-onirique, dépressive)
Parakinésies (gestes impulsifs et compulsifs, rituels, tics, dyskinésie, akathisie, dyskinésie, tremor, stéréotypie, maniérisme, échokinésie, échopraxie, onychophagie, trichotilomanie)
Catatonie
Clinophilie (le fait de rester une grande partie de la journée au lit)
Mimique (amimie, hypermimie, hypomimie)

• maniérisme : Gestuelles, mimique, langage extravagants, saugrenus

• écholalie (ou échopraxie) : tendance involontaire spontanée à répéter ou imiter la parole d'un autre individu

≠ provoqué (le patient ne répond que si on lui pose des questions)

7. Langage (aspects formels du discours, pas le contenu)

Forme générale	Spontané, hésitant, chargé d'émotion, tragique, monotonie, inarticulé, saccadé, cohérent, riche, informatif, ...
Ton	Monotone, exalté, expressif, vociférant, hypophonie (diminution du ton de la voix), aphonie, parle fort, chuchote, ...
Débit	Lent (bradyphémie), rapide (tachyphémie), logorrhéique, laconisme, loquacité, barrage, fading
Mode	Dialogue, monologue, soliloque, discours hallucinatoire, mutique
Articulation	Dysarthrie, dysphasie, dyslalie, bredouillement, bégaiement
Sémantique	Transformations phonémiques (paraphrasie phonémique) Transformations verbales (néologisme = fabrication de mot inexistant, paralogisme = utilisation de mots habituels dans un sens personnel, mot de prédilection, jargonophilie, glossolalie = emploi d'un langage inventé avec son vocabulaire et des éléments de syntaxe incompréhensible par autrui)
Syntaxe	Agrammatisme = perte de la capacité d'organiser une phrase selon les règles de syntaxe
Production	Stock verbal réduit Manque de mot Persévération verbale Echolalie = répétition involontaire, immédiate et dénuée de sens des derniers mots entendus par le patient Stéréotypie verbale = répétition de mot/phrase hors de propos et sans signification

8. Troubles formels de la pensée (cours de la pensée)

Cours de la pensée = déroulement de la pensée, manière dont elle est organisée. Si on a des difficultés à suivre la conversation / comprendre ce que veut dire le patient.

Rythme : pensée inhibée (freinée, bloquée), pensée ralentie (latence des réponses, lenteur du discours), pensée circonscrite (pleine de détails inutiles, pas de perte du fil), pensée digressive ou fuite des idées (afflux d'idées en changement permanent (thèmes) ou qui se perd en raison d'associations intercurrentes), pensée accélérée, pensée rétrograde.

Cohérence : persévération verbale, ruminations, idées envahissantes, réponse à côté, barrage de la pensée, pensée incohérente, néologisme, associations par assonance, coq à l'âne, relâchements des associations. L'ajout sur les mêmes sujets. Léger/moyen/sévère. Suspension brusque de la pensée qui était fluide jusqu'alors.

9-10. Troubles du contenu de la pensée

Craintes et obsessions : méfiance non-délirante, hypochondrie non-délirante, phobie, obsessions (idées qui s'imposent de façon répétée, vécues comme absurdes), obsessions-impulsions (poussent le sujet à un acte), compulsions (geste accompli sous contrainte d'une idée obsédante).

Délire : pressentiment délirant, perception délirante (attribution d'une signification anormale à une saisie perceptive normale), intuition délirante (conviction délirante sans support perceptif), idées délirantes non-systématisées, systématisation du délire, dynamisme du délire (participation affective au délire), idées délirantes de référence, de persécution, de jalousie, de culpabilité, de ruine, hypochondriaques, de grandeur.

11. Troubles des perceptions

Illusions (perception fautive du réel), pseudo-hallucinations, hallucinations acoustico-verbales, hallucinations auditives, hallucinations visuelles, cénesthésiques, olfactives, gustatives.

* le délire est dit systématisé si la croyance paraît aux yeux du clinicien comme cohérente

Personnes, objets, environnement paraissent terribles, étranges, déformés
↑ Monde extérieur semble non familier, bizarre, fantomatique

12. Troubles du moi

Déréalisation/étrangeté, dépersonnalisation → trouble du vécu de l'unité du moi dans l'instant / de l'identité au cours de la vie

Phénomènes d'automatisme mental : devinement de la pensée, vol de la pensée, pensée imposée, écho de la pensée

→ croire que les autres peuvent lire les propres pensées

→ les pensées du patient lui sont encrées par quelqu'un d'autre

→ les pensées sont perçues comme influencées, fabriquées, dirigées de l'extérieur

13. Troubles affectifs

Humeur (subjectif) : description de l'état émotionnel du patient par lui-même

Thymie: triste, bonne, neutre, déprimée, désespérée, irritable, anxieuse, colérique, expansive, euphorique, vide, coupable, respectueuse, futile, terrorisée, perplexe, ...

Affects (objectif) = aspect observable des émotions: exprimé par l'expression faciale, la posture du corps et le ton de la voix

Présents, exprimés

Adaptés / adéquats ou décalés par rapport à la situation, discordance affective (incongruent) → patient avec thymie triste, mais qui sourit ou rigole pdt consultation

Modulés, variés

Monotone, contrôlés, inhibés, restreint

Emoussement de l'affect

Isolation de l'affect

→ sujet donne l'impression de ne plus pouvoir se situer sur le plan affectif

Perplexité, anesthésie affective (désintérêt, appauvrissement des sentiments, indifférence émotionnelle),

vide affectif, humeur déprimée, perte d'espoir,

Sentiment d'insuffisance, de culpabilité ou de ruine

Euthymie, euphorie, dysphorie, irritabilité

Ambivalence affective, discordance affective, labilité affective, incontinence affective, monotonie affective (absence d'oscillation de l'affect en fonction de ce qui est discuté ou vécu), abrasement ou émoussement affectif

accablant, grincheux, morose, bougon, mécontent, agacé

À la suite d'un faible stimulus, émergence soudaine de réactions affectives incontrôlables

↓ capacité de modulation affective

14. Sommeil / Appétit

Sommeil (trouble de l'endormissement, réveils nocturnes, réveil matinal, insomnie, hypersomnie, cauchemars, somnolence diurne, narcolepsie) → 100% accès de sommeil incontrôlable et cataplexie (perte du tonus dûe à des émotions)

Appétit (augmenté, diminué, inchangé, perte ou prise de poids, troubles du comportement alimentaire)

15. Symptômes de la lignée anxieuse

Anticipation anxieuse, anxiété en situation sociale, anxiété observée

Symptômes neurovégétatifs : palpitations, tachycardie, sueurs, hyperventilation, souffle coupé, sensation d'étouffement, d'étourdissement ou sentiment d'irréalité, troubles gastro-intestinaux (hypersalivation, sécheresse buccale, difficultés de déglutition, vomissements, diarrhées), plaintes céphaliques, dorsalgies, lombalgies, lourdeur des jambes, sensation de chaleur, frilosité

16. Somatique

Douleurs, symptômes neuro-végétatifs, ...

17. Substances

OH, toxiques, ...

18. Jugement et insight

Insight : capacité de reconnaître et comprendre ses propres symptômes

Jugement : capacité de prendre des décisions juste dans son propre intérêt, de se comporter de manière socialement acceptée et de coopérer au traitement

Aide à l'évaluation clinique du potentiel suicidaire (UDR)

Urgence

Rencontrer la personne et parler du processus suicidaire

L'évaluation temporelle des pensées et des mises en acte suicidaire* permet de faire émerger au travers de la narration les idées, les plans, mais aussi leurs mises en action (gestes, achats, repérages de lieux, lettre, etc...), afin de comprendre l'évolution et la dynamique du processus suicidaire. Elle se fait en quatre étapes :

- 1.- les **idées et conduites** suicidaires (ICS) ayant motivé la consultation (voir plus bas pour les « suicidants »)
- 2.- les ICS récentes (au cours des 2 derniers mois)
- 3.- les ICS passées
- 4.- les ICS immédiates et futures

Principaux aspects à approfondir auprès d'un suicidant :

Méthode utilisée (moyen, contexte du lieu)	Regret du geste accompli	Hallucinations associées au geste
Contexte des mesures de secours	Prise de conscience de la gravité du geste	Impulsivité
Degré d'intentionnalité	Facteurs précipitants	Compréhension / interprétation du geste
Préparatifs	Substances associées au geste	

*: « Évaluation du potentiel suicidaire », S.C. Shea, 2008

Danger

Parler de l'accessibilité au(x) moyen(s) et du(es) scénario(s) présent(s) ET passé(s)

Il s'agit surtout d'évaluer avec précision l'**accessibilité** directe et immédiate à un moyen de se suicider en questionnant ouvertement la personne suicidaire sur ses intentions, tel que : médicaments, arme à feu, corde, etc. Dans la mesure du possible, il est recommandé d'intervenir sur le(s) moyen(s) afin de faire diminuer le danger. (p.ex. : faire appel à la police pour retirer une arme à feu, retirer les médicaments non nécessaires) ce en toute transparence et en accord avec la personne.

Risques actuels

Faire émerger les facteurs précipitants et identifier les signaux d'alerte

Facteurs précipitants (non exhaustifs) :

Pertes réelles ou ressenties (décès, divorce, rupture affective, emploi...),
Échecs (professionnels, scolaires, projets personnels),
Humiliation, violence (scolaire, publique...),
Conflit interpersonnel,
Diagnostic d'une maladie mentale,
Diagnostic d'une maladie mortelle ou gravement handicapante,
Difficultés financières,
Accès à une arme à feu,
Tentative de suicide ou suicide d'un proche,
Isolement social, Privation de liberté,
Hallucination impérieuse, sensation d'être contrôlé par un autre, préoccupation religieuse, ...

Signaux d'alerte :

Désespoir,
Rage, colère, recherche à se venger,
Agir avec imprudence ou se livrer à des comportements à risque,
Se sentir piégé (sans porte de sortie),
Augmentation de la consommation d'alcool ou de drogues,
Retrait (famille - proches - société),
Anxiété,
Agitation,
Insomnie ou l'hypersomnie,
Changements d'humeur importants,
Plus de raison de vivre (perte de sens et de but dans la vie)

Risques épidémiologiques et facteurs protecteurs :

Rencontrer la personne dans son parcours de vie en identifiant ses facteurs prédisposants et l'ensemble de ses ressources

Facteurs prédisposants (non exhaustifs) :

Individuels

Antécédents suicidaires,
Présence et gravité de problème de santé mentale (psychopathologie y.c. addiction),
Faible estime de soi,
Impulsivité, agressivité,
Problèmes somatiques /douleurs chroniques,
Orientation sexuelle, et identité de genre atypique,
Violence physique, sexuelle, fugue, IVG,...

Familiaux

Violence, abus physique, psychologique ou sexuel,
Relation conflictuelle avec les parents /enfants,
Négligence de la part des parents /enfants,
Conflits avec le partenaire, conflits familiaux,
Comportements suicidaires chez un parent/enfant/conjoint,
Problèmes de santé mentale d'un parent/enfant/conjoint, ...

Psychosociaux

Difficultés économiques persistantes,
Isolement social et affectif,
Séparation, rupture, perte, deuil,
Placement foyer / institution / EMS / détention,
Difficultés scolaires, professionnelles, retraite,
Effet de contagion à la suite d'un suicide,
Problèmes d'intégration sociale, migration, déménagement, ...

Facteurs protecteurs

Stratégies d'adaptation déjà utilisées - Famille, proches - Relation interpersonnelle stable et soutenante - Réseau de soins - Vivre en couple - Avoir la foi, croyance - Avoir des projets - Pouvoir exprimer et communiquer ses inquiétudes angoisses - ...

Recommandation :

Urgence suicidaire :

La personne envisage clairement un scénario (où, comment)
Le moyen envisagé dans le scénario est accessible et avec une létalité importante (p. ex. : une arme à feu)
Présence et intensité de facteurs précipitants et des signaux d'alerte
Diminution de la peur de la mort et/ou augmentation de la tolérance à la souffrance physique

En cas d'urgence suicidaire, l'intervenant doit mettre en place une intervention, idéalement en toute transparence et en partenariat avec la personne suicidaire. L'urgence suicidaire nécessite une réponse individualisée. Les éléments perturbateurs, la qualité relationnelle, la présence d'une maladie psychiatrique, seront également intégrés dans la réflexion. L'appel à un regard tiers, en présence ou par téléphone, devrait précéder toute prise de décision. L'évaluation du potentiel suicidaire doit être intégrée à l'évaluation clinique globale et documentée dans l'attitude générale.